

Introduzione al modulo di Salute mentale

Salute mentale · Sessione 01 · 18.02.2026

Questa lezione costruisce le fondamenta del modulo: distingue salute, benessere e normalità, mostra quanto il linguaggio condizioni lo sguardo sulla sofferenza psichica e chiarisce quale posizione può assumere una persona davanti alla malattia. Per il lavoro sociale, capire queste distinzioni significa evitare etichette facili e accompagnare la persona nella sua interezza.

Struttura e orientamento del modulo

Il modulo affronta il **patire**, il disagio e le sofferenze psichiche che l'operatore sociale incontrerà nei diversi ambiti professionali. L'approccio deriva dalla scuola fenomenologica e si organizza in tre tappe:

1. **Clinica**: incontro con chi soffre, concetti di salute e malattia, normalità e patologia, empatia e meccanismi di difesa.
2. **Mondo**: funzioni psichiche e loro alterazioni, poi descrizione nosografica di sindromi affettive e ansiose, disturbi di personalità, nevrosi e psicosi.
3. **Corpo**: corpo come luogo ed espressione della sofferenza, con temi quali aggressività, violenza, anoressia-bulimia, sessualità e alessitimia.

Le tre tappe sono attraversate da quattro dimensioni esistenziali: **spazio, tempo, identità e incontro**. La relazione nasce solo dopo un incontro reale con l'altro; il suo mondo e la sua esperienza modificano il modo in cui vive spazio, tempo, corpo e identità.

L'operatore sociale agisce come **trait d'union** tra discipline specialistiche: non deve sostituirsi al clinico, ma conoscere il linguaggio psicopatologico e possedere

competenze relazionali per evitare che la persona venga frammentata in singoli problemi.

Che cosa significa "clinica"

Clinica deriva dal greco *klinein*, "chinarsi". Indica il chinarsi sul letto reale o metaforico di chi soffre, con umiltà e premura. Il curante, in questa prospettiva, non è soltanto il medico: è chiunque si prende cura della persona che porta su di sé il proprio patire.

La formula importante è **presa in cura**, non semplice "presa in carico": al centro resta una persona con cui si costruisce un incontro, non un caso da amministrare.

Salute, benessere e normalità

I tre concetti vengono spesso sovrapposti, ma indicano piani differenti:

Concetto	Domanda centrale	Piano prevalente
Salute	Come funziona la persona e quali potenzialità possiede?	Funzionale e biomedico
Benessere	Come si sente la persona nella propria vita?	Soggettivo e multidimensionale
Normalità	Quanto la persona è conforme a una media, un ideale o il proprio funzionamento abituale?	Statistico, culturale e personale

Essere fuori dalla norma non significa automaticamente essere malati; essere in salute non garantisce il benessere; sentirsi bene non esclude una malattia.

Un'immagine utile è quella di una pianta: la salute riguarda anche le sue funzioni vitali, il benessere riguarda le condizioni complessive in cui riesce a vivere, mentre la normalità dipende dal confronto scelto. Una pianta insolita non è per questo malata.

Disease, illness e sickness

La lingua inglese distingue tre dimensioni che in italiano tendono a confondersi:

- **Disease**: condizione biomedica certificabile e misurabile attraverso segni, esami e parametri clinici.
- **Illness**: esperienza soggettiva della malattia, cioè come la persona vive e interpreta ciò che le accade.
- **Sickness**: riconoscimento sociale della condizione e ruolo attribuito alla persona malata, compresi etichettamento e stigma.

Le tre dimensioni possono presentarsi insieme oppure separatamente. Una persona può avere una *disease* senza avvertire sintomi; può sentirsi male senza una certificazione clinica; può ricevere un'etichetta sociale anche quando le altre due dimensioni non sono riconosciute.

Per il lavoro sociale la *sickness* è decisiva: il giudizio della società può offrire riconoscimento e accesso all'aiuto, ma può anche trasformarsi in stigma, colpevolizzazione ed esclusione.

La salute secondo Christopher Boorse

Nel testo *Health as a Theoretical Concept* (1977), **Christopher Boorse** analizza sette idee comunemente usate per definire salute e malattia. Nessuna, presa da sola, è una condizione necessaria e sufficiente.

Criterio	Perché non basta
Salute come valore	Ciò che è desiderabile varia tra persone, culture e situazioni; in guerra, per esempio, non essere idonei può evitare il fronte.
Malattia come ciò che il medico tratta	Non tutte le malattie vengono trattate e la medicina interviene anche in condizioni non patologiche, come gravidanza e adolescenza.

Criterio	Perché non basta
Salute come norma statistica	Frequente non equivale a sano e raro non equivale a malato; l'omosessualità mostra i rischi storici di questa equivalenza.
Malattia come disagio o sofferenza	Esistono malattie asintomatiche e dolori fisiologici, come dentizione, mestruazioni o fatica muscolare.
Malattia come disabilità	Una funzione assente o ridotta non indica sempre malattia: il neonato non cammina e durante il sonno molte abilità non vengono esercitate.
Salute come adattamento all'ambiente	L'essere umano modifica anche l'ambiente; nelle disabilità e neurodivergenze può essere il contesto a dover diventare accessibile.
Salute come omeostasi	Molte funzioni vitali rompono l'equilibrio: crescita, riproduzione, percezione e locomozione.

Equilibrio come processo

Il docente insiste sul limite dell'equilibrio statico. Per camminare bisogna perdere e ritrovare continuamente l'equilibrio; allo stesso modo, vivere e crescere richiede trasformazioni.

La salute non è immobilità perfetta, ma capacità di attraversare squilibri e riorganizzarsi. Un equilibrio incapace di cambiare diventa rigidità.

Il benessere e le sue variabili

La salute è importante per la qualità della vita, ma non la produce automaticamente. Il manuale ricorda che persone con malattie croniche possono ritrovare senso, desideri e relazioni profonde; al contrario, una persona clinicamente sana può vivere senza soddisfazione.

Il docente cita Tiziano Terzani e *Un altro giro di giostra*: la malattia può mettere in crisi la vita, ma anche cambiare il peso attribuito alle cose e aprire una diversa esperienza di benessere.

Le sei dimensioni di Carol Ryff

Secondo **Carol Ryff**, il benessere psicologico comprende sei componenti:

Dimensione	Significato
Autoaccettazione	Avere un atteggiamento positivo verso di sé, riconoscendo qualità, limiti e percorso di vita.
Relazioni positive	Vivere rapporti caratterizzati da fiducia, calore, affetto, intimità e reciprocità.
Autonomia	Regolarsi in modo indipendente senza dipendere interamente da pressioni e aspettative sociali.
Controllo ambientale	Riconoscere e valorizzare opportunità e risorse presenti nell'ambiente.
Percezione di crescita	Leggere la propria vita come sviluppo continuo e apertura al cambiamento.
Scopo nella vita	Avere mete e attribuire significato alle proprie azioni e ai propri sacrifici.

Il modello rende operativo il lavoro sul benessere: invece di chiedere soltanto "stai bene?", l'operatore può esplorare quale dimensione è fragile e quali risorse possono essere attivate.

Dal benessere alla malattia mentale

Fulcheri descrive un continuum dinamico, con possibili passaggi e reversibilità:

Condizione	Elementi principali
Benessere psichico	Bisogni sufficientemente soddisfatti, qualità di vita positiva, accettazione della propria condizione.
Disagio psichico	Inquietudine, frustrazione, tristezza o aggressività legate a difficoltà; non vi sono ancora sintomi specifici.
Malessere psichico	Sofferenza più intensa e consapevolezza di non stare bene, anche con stanchezza, tensione o sensazioni corporee.
Disturbo psichico	La sofferenza non trova soluzione, è intensa e si accompagna a sintomi clinici e alterazioni del comportamento.
Malattia mentale	Le alterazioni mentali e comportamentali persistono nel tempo e si stabilizzano.

Queste categorie aiutano a orientarsi, ma non autorizzano diagnosi automatiche: intensità, durata, contesto, compromissione della vita e vissuto soggettivo vanno considerati insieme.

Le tre normalità

Norma statistica

Definisce normale ciò che si colloca nella media di una popolazione o di un gruppo. È relativa al campione e al contesto: un comportamento frequente in un sottogruppo può essere raro altrove.

Konrad Lorenz, osservato mentre procedeva a quattro zampe senza che gli spettatori vedessero gli anatroccoli che lo seguivano, appariva "strano". Il contesto trasformava completamente il significato della condotta.

Norma di valore

Confronta la persona con uno standard ideale o desiderabile. Una condotta può essere statisticamente frequente ma lontana dall'ideale scelto.

Anche l'operatore possiede immagini ideali dell'utente, dell'autonomia e del cambiamento. Se non le riconosce, rischia di imporle e di valutare la persona come insufficiente.

Norma individuale

Confronta la persona con il proprio funzionamento abituale. Malattia, trauma o invecchiamento possono produrre una rottura tra un "prima" e un "dopo".

La norma precedente non è però sempre recuperabile né sempre desiderabile. Tornare a lavorare dieci ore al giorno, se quella modalità ha contribuito al crollo, non coincide necessariamente con la cura.

Nel progetto sociale non si tratta sempre di restaurare il passato, ma di costruire un nuovo funzionamento possibile e significativo.

La posizione del soggetto davanti alla malattia

Il modello usa due assi:

- **Identificazione:** la condizione viene sentita come parte di sé oppure come elemento estraneo da espellere.
- **Agentività:** la persona si percepisce capace di agire sulla propria vita oppure delega e subisce gli eventi.

L'incrocio produce quattro posizioni:

Posizione	Identificazione	Agentività	Orientamento
Combatto	No	Alta	La condizione è un nemico da eliminare; la persona cerca attivamente la guarigione.
Guariscimi	No	Bassa	La condizione è estranea, ma la persona delega allo specialista il compito di eliminarla.
Mi curo	Sì	Alta	

Posizione	Identificazione	Agentività	Orientamento
			La persona integra la condizione e cerca attivamente benessere e autonomia, anche senza guarigione.
Cura-mi	Sì	Bassa	La persona riconosce la condizione ma delega ad altri il miglioramento della propria vita.

La parte alta della matrice è l'**area dell'alleanza**, perché il soggetto partecipa al percorso. La parte bassa è l'**area della delega**. Le posizioni non sono identità fisse: una persona può spostarsi nel tempo grazie a competenze, sostegno ed esperienza.

To cure e to care

To cure indica l'intervento terapeutico rivolto alla guarigione; **to care** indica il prendersi cura della persona e del suo benessere. La terapia non è sempre disponibile o efficace, mentre la cura rimane praticabile anche nelle condizioni croniche o non guaribili.

Per il lavoro sociale, aumentare agentività e qualità della vita non è un ripiego: è un obiettivo centrale della cura.

Elementi salienti della salute mentale

Definire la salute mentale soltanto come assenza di disturbo è riduttivo. Il materiale evidenzia alcuni elementi:

- è parte inseparabile della salute generale;
- riguarda il benessere e la realizzazione di sé;
- comprende la capacità di affrontare tensioni e difficoltà;
- implica partecipazione alla vita produttiva e comunitaria;
- nasce dall'interazione tra predisposizioni, biografia, comportamenti, cultura, condizioni sociali, economiche, politiche e ambientali;

- riguarda la relazione con sé, con gli altri e con il mondo;
- richiede uno sguardo rispettoso che contrasti stigma e colpevolizzazione.

La definizione dell'OMS presentata nel manuale descrive la salute mentale come uno stato di benessere nel quale la persona può realizzarsi, superare le tensioni quotidiane, lavorare in modo produttivo e contribuire alla comunità.

La **Carta di Ottawa del 21 novembre 1986** aggiunge un passaggio importante: **la salute è una risorsa per la vita quotidiana, non l'obiettivo finale dell'esistenza, e la sua promozione non appartiene soltanto al settore sanitario.**

Comportamento, contesto e relazione

Il comportamento è spesso il primo elemento osservabile, ma non può essere separato dal contesto. Imprevedibilità, scarsa controllabilità e apparente irrazionalità possono allarmare l'osservatore e favorire un giudizio di devianza.

Secondo il materiale, la malattia mentale non è riducibile a un guasto interno all'individuo. Può manifestarsi come difficoltà nel rapporto intersoggettivo, nella comunicazione e nella comprensione reciproca. La salute psichica comprende allora anche una capacità dialogica tra le diverse parti della psiche e nella relazione con gli altri.

Linguaggio e salute mentale

Le parole non descrivono soltanto: orientano lo sguardo e possono assegnare identità.

- **Matto** richiama un agire incontrollato o improprio rispetto alle aspettative sociali.
- **Follia** rimanda etimologicamente al sacco pieno d'aria, quindi a vuoto e perdita di senso; questa immagine rischia di svalutare tutto ciò che la persona dice.
- **Pazzia** contiene riferimenti al *pathos*, alla sofferenza e alla furia.
- **Alienato** deriva da *alienus*, estraneo, e può spingere a non riconoscere nell'altro un'umanità comune.

- **Delirio** richiama l'uscita dal solco dell'aratro e quindi la deviazione da un percorso condiviso.

Ciò che appare privo di senso può segnalare soprattutto il limite di comprensione dell'osservatore, non l'assenza di significato nell'esperienza della persona.

Cargnello osserva inoltre che per la sofferenza mentale si usa spesso il verbo **essere** ("è schizofrenico", "è demente"), mentre per molte malattie fisiche prevale **avere** ("ha un tumore", "ha una polmonite"). L'uso di *essere* fonde la diagnosi con l'identità.

Dire "persona con schizofrenia" invece di "schizofrenico" non è un dettaglio cosmetico: conserva la distinzione tra persona e condizione e riduce il rischio di trasformare una diagnosi nell'intera identità.

I quattro snodi della Swiss Public Health Conference

Nel [terzo incontro della Rete Salute Psichica Svizzera](#), svoltosi a Olten il 21-22 agosto 2014 nell'ambito della [Swiss Public Health Conference](#), un manifesto ha proposto quattro snodi:

1. **La salute psichica è un processo:** comprende sviluppo emozionale, intellettuale e professionale, superamento delle difficoltà e contributo alla società. Dipende da condizioni individuali, sociali, culturali, economiche e politiche.
2. **Non c'è salute senza salute psichica:** salute fisica, psichica e sociale sono equivalenti e interdipendenti; le conoscenze sulla dimensione psichica vanno integrate in tutti gli ambiti.
3. **La salute psichica è complessa:** deriva dall'interazione tra predisposizione, biografia, comportamento, cultura, comunità e ambiente. Una società sana combatte pregiudizio, colpevolizzazione e stigma.
4. **La salute psichica è una sfida permanente:** ogni età e situazione di vita presenta compiti che possono attivare risorse o disturbi; un sostegno adeguato orienta positivamente il processo.

Un buon tag mentale per ricordarli è **P-I-C-S: Processo, Interdipendenza, Complessità, Sfida**.

Tragedia greca, passioni e follia

Il modulo affianca alla teoria il lavoro su cinque tragedie: lettura, confronto nel gruppo, sintesi, scrittura scenica e rappresentazione. L'attività allena ascolto di linguaggi non familiari, collaborazione, capacità di scegliere e rinunciare a parti del materiale.

La tragedia mette pubblicamente in scena sofferenza, follia e disperazione. Attraverso la **catarsi**, lo spettatore incontra emozioni difficili e sposta il proprio sguardo sui confini dell'umano.

I tre tragediografi vengono distinti così:

- **Eschilo**: la follia giunge dagli dèi come forza esterna.
- **Sofocle**: il tragico appartiene alla vita stessa.
- **Euripide**: il tragico nasce soprattutto nelle relazioni umane.

Le tragedie scelte per il 2026 convergono sulla violenza contro le donne nei conflitti. Il collegamento con deportazioni, schiavitù sessuale e guerre contemporanee mostra che il testo antico continua a interrogare il presente.

Il lavoro prevede anche l'incontro con il **Club '74**, nato nel clima di trasformazione degli anni Settanta. Non è pensato come semplice fornitore di materiali: la collaborazione deve essere reciproca e basata sull'incontro con le persone.

Secondo il docente, il lavoro sociale ha inevitabilmente una dimensione politica: nelle pratiche quotidiane decide chi viene riconosciuto, incluso e ascoltato e quanto i principi di partecipazione diventino reali.

Concetti chiave

Termine	Significato
Clinica	Incontro e presa in cura di chi soffre; dal greco <i>klinein</i> , chinarsi.
Disease	Dimensione biomedica e certificabile della malattia.
Illness	Esperienza soggettiva della persona.
Sickness	Dimensione e riconoscimento sociale della malattia.
Benessere	Costrutto soggettivo e multidimensionale, non sinonimo di salute.
Norma statistica	Conformità alla media di una popolazione o di un gruppo.
Norma di valore	Conformità a un ideale ritenuto desiderabile.
Norma individuale	Confronto con il funzionamento abituale della stessa persona.
Agentività	Percezione di poter agire sulla propria condizione e sulla propria vita.
Identificazione	Riconoscimento della condizione come parte di sé.
To cure	Trattare con l'obiettivo della guarigione.
To care	Prendersi cura della persona e del suo benessere.
Stigma	Etichetta sociale negativa che svaluta ed esclude.
Catarsi	Elaborazione emotiva favorita dalla rappresentazione tragica.

Domande di orientamento allo studio

Perché salute, benessere e normalità non sono sinonimi? La salute riguarda funzionalità e potenzialità, il benessere il vissuto soggettivo, mentre la normalità dipende dal confronto con una media, un ideale o il funzionamento precedente. I tre piani si influenzano ma possono non coincidere: una persona può essere malata e percepire benessere, oppure essere statisticamente atipica senza avere una patologia.

Perché il contesto è indispensabile per interpretare un comportamento?

Lo stesso gesto può assumere significati differenti secondo cultura, situazione e relazioni. Senza contesto si rischia di scambiare per sintomo ciò che è comprensibile nella situazione concreta e di trasformare la devianza sociale in malattia.

Come cambia l'intervento passando da guarigione a cura? La guarigione mira a eliminare la condizione; la cura lavora sulla qualità della vita anche quando la condizione permane. L'operatore sostiene agentività, risorse, relazioni e partecipazione invece di misurare ogni esito soltanto con la scomparsa della malattia.

Perché il linguaggio può produrre stigma? Parole ed espressioni possono fondere la persona con la diagnosi, attribuirle estraneità o negare significato a ciò che comunica. Usare un linguaggio centrato sulla persona conserva identità e dignità e mantiene aperta la possibilità di comprensione.

Domande esame 01

1. Che cosa si intende per salute? La salute è un concetto complesso legato al funzionamento e alle potenzialità della persona, ma non può essere ridotta a un singolo criterio né alla sola assenza di malattia. Va considerata nelle dimensioni biomedica, soggettiva e sociale e come risorsa dinamica per la vita quotidiana.

2. Qual è la differenza tra benessere, disagio, malessere e disturbo? Il benessere implica soddisfazione dei bisogni, qualità di vita e accettazione. Il disagio è una sofferenza ancora priva di sintomi specifici; nel malessere aumentano intensità e consapevolezza di non stare bene, anche con sensazioni corporee. Nel

disturbo la sofferenza è elevata, persistente e accompagnata da sintomi clinici e alterazioni del comportamento; la malattia mentale indica una maggiore stabilizzazione nel tempo.

3. Quali concetti di normalità vengono presentati? La normalità statistica coincide con la media del gruppo, la norma di valore con un ideale desiderabile e la norma individuale con il funzionamento abituale della persona. Nessuna coincide automaticamente con la salute: l'anormalità può non essere patologica e il ritorno alla normalità precedente può non essere possibile o utile.

4. Come si distinguono disease, illness e sickness? *Disease* è la malattia biomedica certificabile; *illness* è il vissuto soggettivo; *sickness* è il riconoscimento e l'etichettamento sociale. Le tre dimensioni possono combinarsi oppure non coincidere e richiedono quindi sguardi professionali differenti ma coordinati.

5. Quali definizioni di salute e malattia analizza Boorse? Boorse analizza salute come valore, malattia come oggetto di trattamento medico, salute come norma statistica, malattia come disagio o sofferenza, malattia come disabilità, salute come adattamento e salute come omeostasi. Per ciascun criterio individua eccezioni; nessuno è da solo necessario e sufficiente.

6. Quali sono le variabili del benessere secondo Ryff? Sono autoaccettazione, relazioni positive, autonomia, controllo ambientale, percezione di crescita e scopo nella vita. Il benessere deriva dalla loro configurazione complessiva e non dalla perfezione uniforme di tutte le dimensioni.

7. Quali posizioni può assumere il soggetto davanti alla malattia? Incrociando identificazione e agentività emergono quattro posizioni: *Combatto*, *Guarisci-mi*, *Mi curo* e *Cura-mi*. Le prime due considerano la malattia estranea; le altre la integrano nella propria condizione. Le posizioni agentive favoriscono alleanza e partecipazione, quelle passive tendono alla delega.

8. Quali sono gli elementi salienti della salute mentale? La salute mentale è parte della salute generale, non semplice assenza di disturbo. Comprende benessere, realizzazione, capacità di affrontare difficoltà, lavoro e partecipazione comunitaria; deriva dall'interazione tra biografia, predisposizioni, relazioni, cultura e condizioni sociali e ambientali.

9. Qual è il rapporto tra linguaggio e salute mentale? Il linguaggio costruisce rappresentazioni sociali e può trasformare una condizione nell'identità totale della persona. Termini come folle, pazzo e alienato portano immagini di vuoto, incontrollabilità ed estraneità; l'uso dell'ausiliare *essere* nelle diagnosi psichiatriche rafforza questa identificazione. Un linguaggio centrato sulla persona limita stigma ed esclusione.

10. Quali sono gli snodi della salute mentale indicati dalla Swiss Public Health Conference? I quattro snodi sono: salute psichica come processo; impossibilità di separarla dalla salute fisica e sociale; complessità delle interazioni che la determinano; carattere permanente della sfida lungo tutte le età della vita. Ne derivano corresponsabilità professionale, integrazione dei saperi, lotta allo stigma e importanza del sostegno.

Collegamenti

- **Lezione successiva:** la storia della follia approfondirà come categorie, istituzioni e parole cambino nel tempo.
- **Incontro ed empatia:** il riconoscimento dell'altro come persona precede ogni classificazione.
- **Meccanismi di difesa:** saranno letti come modi funzionali o disfunzionali di rispondere alle minacce.
- **Lavoro sociale:** partecipazione, accessibilità dell'ambiente, alleanza e contrasto allo stigma collegano tutti i concetti della lezione.